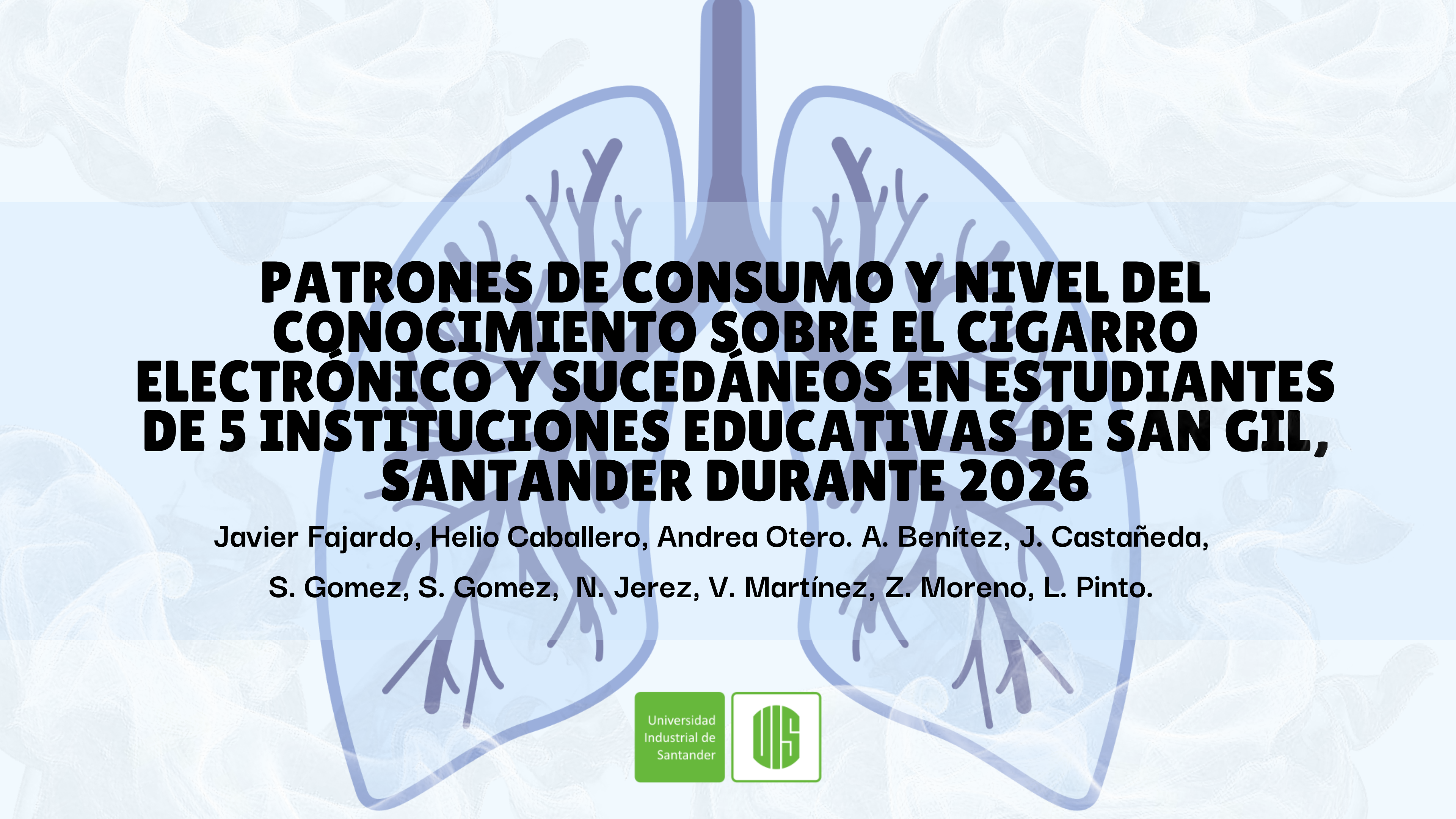




PATRONES DE CONSUMO Y NIVEL DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL CIGARRO ELECTRÓNICO Y SUCEDÁNEOS EN ESTUDIANTES DE 5 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN GIL, SANTANDER DURANTE 2026

Javier Fajardo, Helio Caballero, Andrea Otero. A. Benítez, J. Castañeda,
S. Gomez, S. Gomez, N. Jerez, V. Martínez, Z. Moreno, L. Pinto.

Universidad
Industrial de
Santander



¿POR QUÉ HABLAR DE VAPEO?

- Se comercializa como alternativa "segura" al cigarrillo convencional.
- Alta aceptación en población adolescente.
- No genera combustión, pero contiene nicotina, partículas ultrafinas y sustancias nocivas.



IMPACTO EN SALUD

- Lesión pulmonar asociada al vapeo (EVALI).
- Riesgo cardiovascular.
- Dependencia a nicotina.
- Puerta de entrada a otras sustancias psicoactivas.

CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO



PANORAMA MUNDIAL

Más de 100 millones de usuarios.

Aprox. 15 millones de adolescentes.

LATINOAMERICANA



Prevalencia media agrupada:
18.9%

Factores asociados:

- Curiosidad
- Baja percepción de riesgo
- Sabores atractivos
- Influencia social

COLOMBIA



Edad promedio de inicio:
14.1 años

Tendencia creciente en jóvenes escolares.

Prevalencia:

- 8,3 % (12-14 años)
- 14,8 % (17-18 años)

CONTEXTO LOCAL



San Gil, Santander

Población escolar
proveniente de **zonas
urbanas y rurales.**

Instituciones educativas
públicas y privadas.

A pesar del creciente uso de cigarrillos
electrónicos en adolescentes

No existían estudios
recientes en San Gil.

No se habían identificado

Factores asociados

Nivel de conocimiento

Percepción de riesgo

OBJETIVO

Identificar factores asociados al consumo y conocimiento de cigarrillos electrónicos en escolares de San Gil, Santander en 2026.

METODOLOGÍA

Diseño y Población



Estudio transversal analítico



657 estudiantes de 5 instituciones de San Gil, Santander.



Instrumento

Evaluación de conocimientos de riesgos, percepción de daño y patrones.



Analisis Estadístico

Estadística descriptiva. Análisis bivariado con prueba Chi-cuadrado.

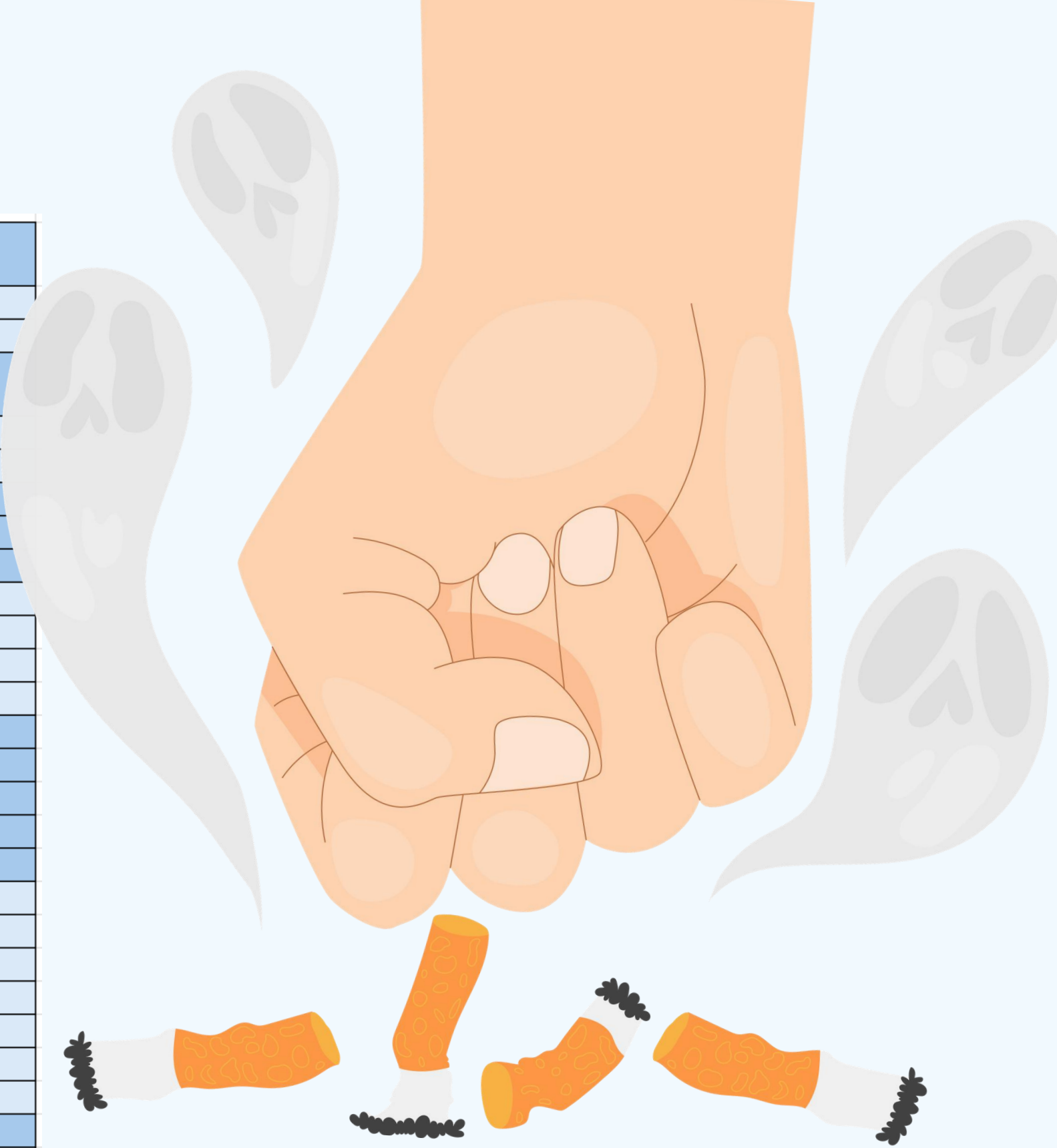


SPSS v.28.

RESULTADOS

Variables Cuantitativas	Media	Mediana	Desviación estándar
Edad en años	13,72	14 (min 10 - máx 20)	1,936
Edad inicio de vapeo	12,84	13 (min 8 - máx 17)	1,917
Variables cualitativas	n		Frecuencia (IC)
Sexo biológico	Hombre	298	45,4%
	Mujer	359	54,6%
Rango de edad	10 a 14 años	432	65,8%
	15 a 17 años	206	31,4%
	18 a 20 años	19	2,9%
Probabilidad de vapeo	Sí	482	73,4%
	No	30	4,6%
	Tal vez	106	16,1%
	No sabe	39	5,9%
Susceptibilidad percibida	Ligeramente peligroso	39	5,9%
	Ligeramente seguro	4	0,6%
	Muy peligroso	141	21,5%
	Peligroso	58	8,8%
	No contestó	415	63,2%
Gravedad percibida	Improbable	4	0,6%
	Muy improbable	39	5,9%
	Poco improbable	3	0,5%
	Poco probable	21	3,2%
	Probable	70	10,7%
	Muy probable	178	27,1%
	No contestó	342	52,1%
Percepción de riesgo ¹	Buena percepción	238	98,3%
	Mala percepción	4	1,7%

Tabla 1. Resultados análisis univariada. ¹ Los porcentajes de percepción del riesgo se calcularon utilizando como denominador únicamente a los participantes que respondieron esta pregunta (n=242). Los 415 estudiantes restantes (63,2%) no respondieron este ítem.



RESULTADOS

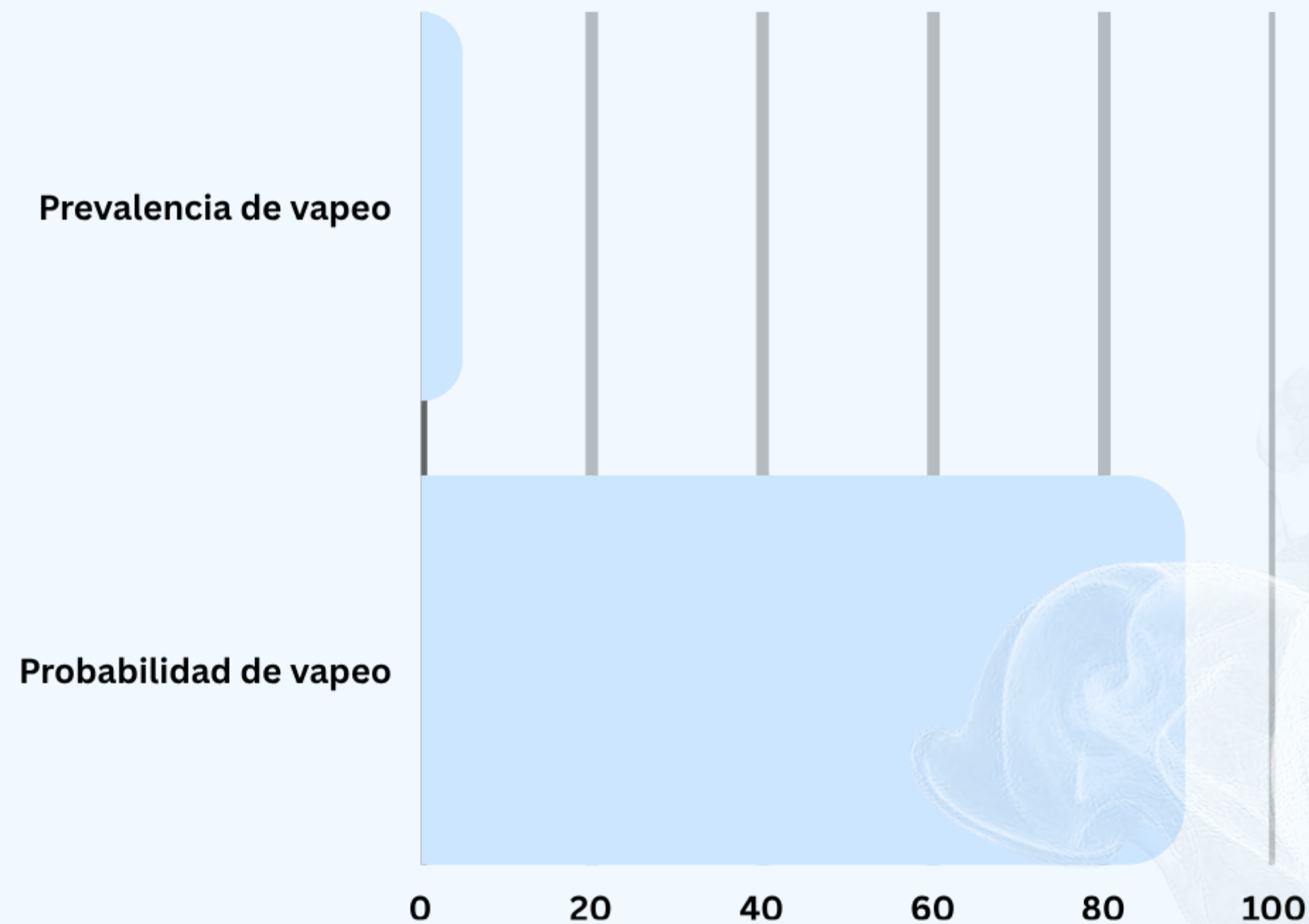


Figura 1. Prevalencia e intención de vapeo. Aunque la prevalencia de vapeo fue del 4,9%, (baja), la probabilidad al consumo futuro (respuesta "sí" o "tal vez") alcanzó el 89,5% de los estudiantes.

RESULTADOS

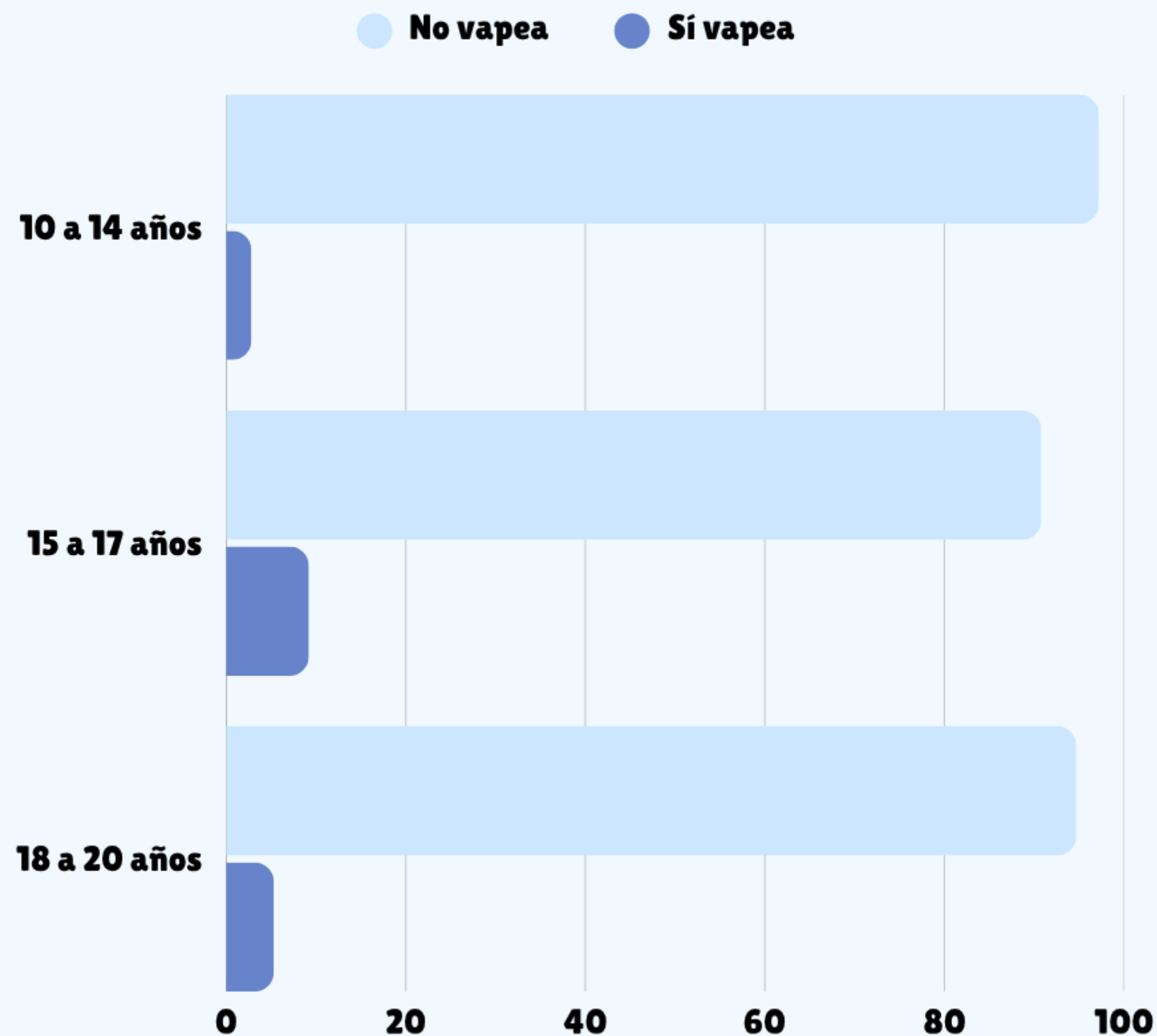
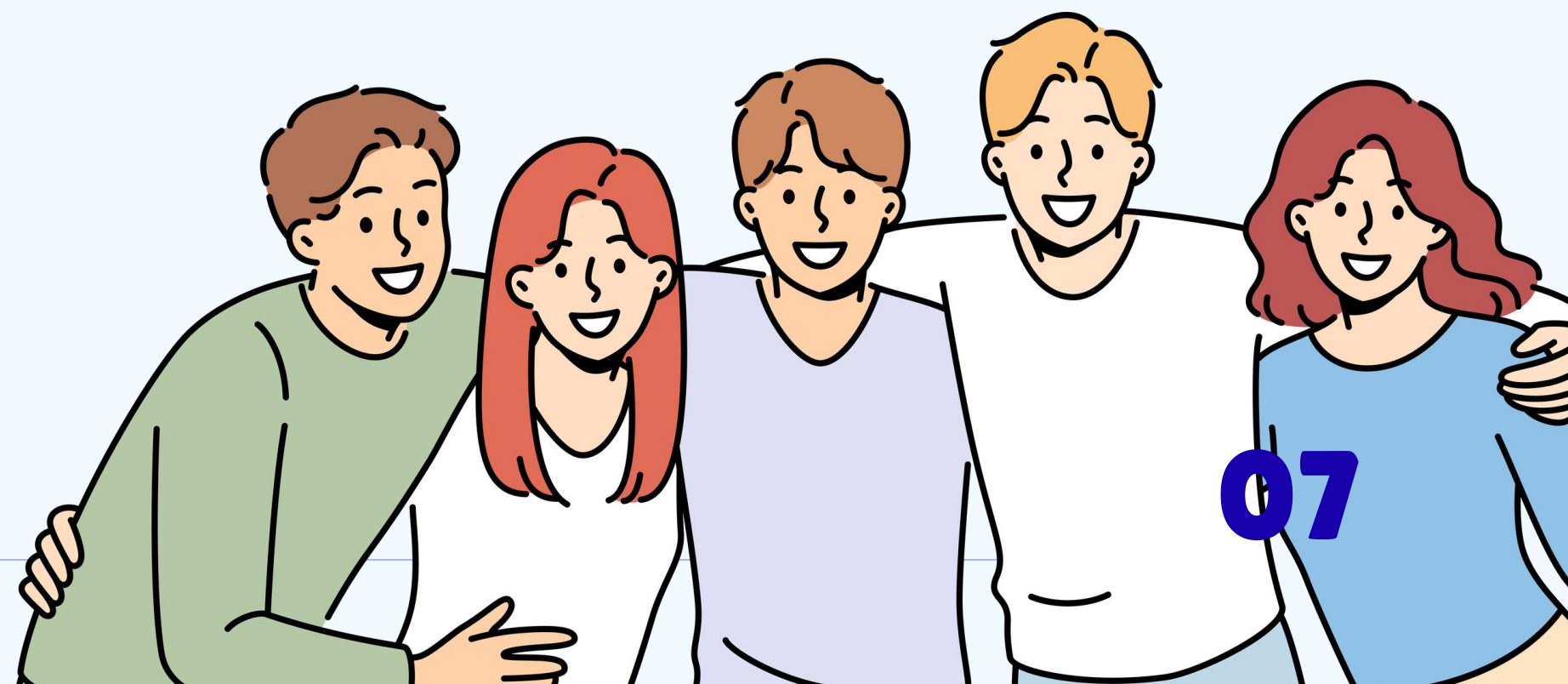


Figura 2. Prevalencia de consumo de vapeo según rango de edad. El mayor porcentaje de consumidores se observó en el grupo de 15 a 17 años (9,2 %) y el menor en el grupo de 10 a 14 años (2,8 %), con una asociación estadísticamente significativa ($p = 0,002$).



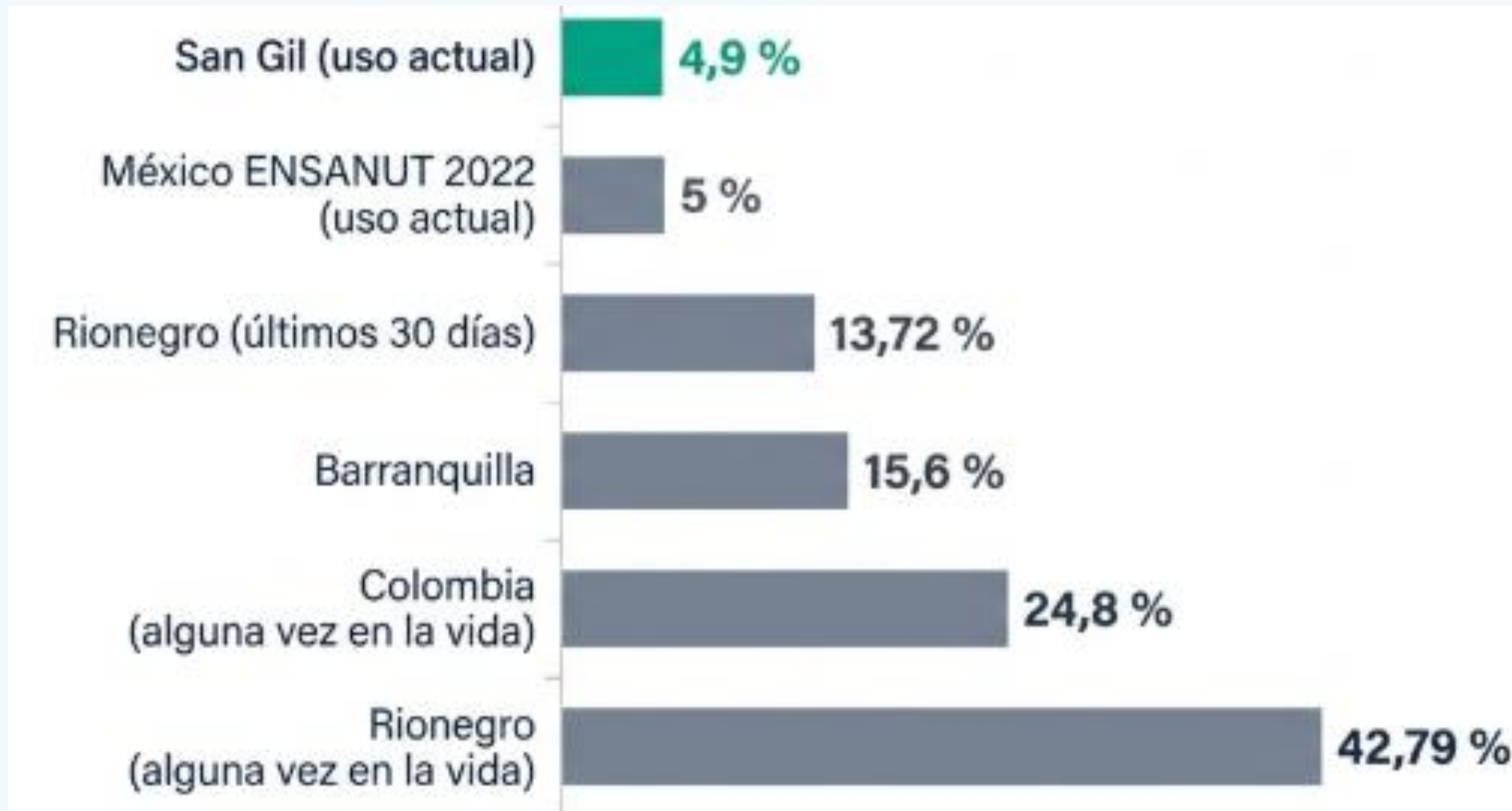
ANALISIS BIVARIADO

	Variable independiente (VA)	Variable dependiente (VR)		Valor p
		% No vapea	% Si vapea	
Sexo	Masculino	92,6	7,4	0,006
	Femenino	97,2	2,8	
Probabilidad de vapeo	Sí	100	0	0,000
	No	100	0	
	Tal vez	100	0	
	No sabe	17,9	82,1	
Susceptibilidad percibida	Ligeramente seguro	25	75	0,000
	Ligeramente peligroso	92,3	7,7	
	Peligroso	94,8	5,2	
	Muy peligroso	98,6	1,4	
Gravedad percibida	Muy probable	97,8	2,2	0,033
	Probable	97,1	2,9	
	Poco probable	90,5	9,5	
	Poco improbable	66,7	33,3	
	Improbable	100	0	
	Muy improbable	92,3	7,7	
Percepción de riesgo	Buena	96,6	3,4	0,000
	Mala	25	75	

Tabla 2. Resultados análisis bivariado



DISCUSIÓN



- San Gil presentó la menor prevalencia entre los estudios comparados.
- La prevalencia es muy similar al uso actual reportado en México.
- Las cifras nacionales son mayores porque la mayoría miden alguna vez en la vida, no el consumo actual.

Figura 3. Prevalencia del vapeo: comparación con el contexto nacional e internacional. Las comparaciones deben interpretarse considerando las diferencias metodológicas entre los estudios.

DISCUSIÓN

¿Por qué la prevalencia fue menor en San Gil?

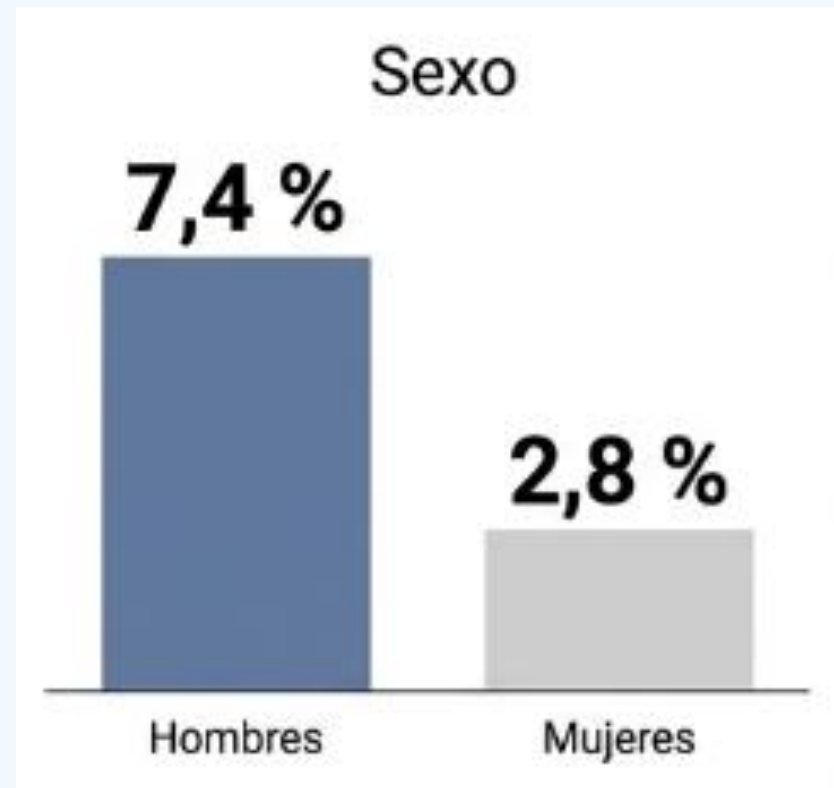


La menor prevalencia probablemente refleja tanto diferencias metodológicas como características propias del contexto de San Gil



DISCUSIÓN

Factores sociodemográficos asociados al consumo de vapeo



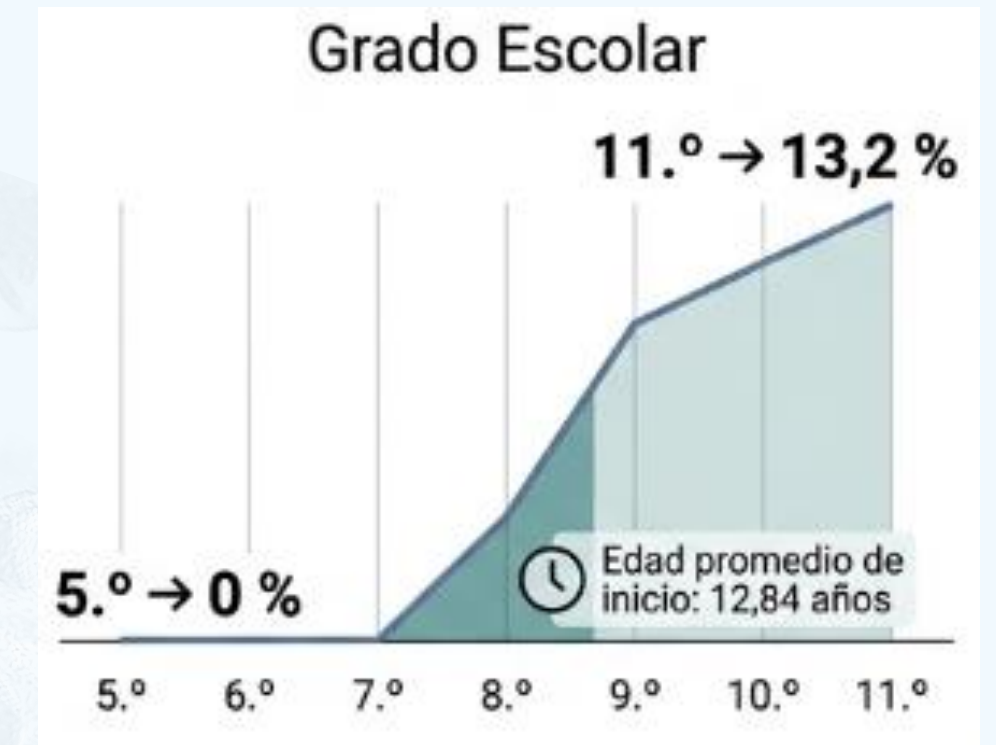
$p = 0.006$

Consistente con estudios de Cartagena y México, donde los hombres presentaron mayor consumo o susceptibilidad al vapeo.



$p = 0.049$

La evidencia internacional no es uniforme. En un estudio realizado en Cusco (Perú) se observó el patrón contrario, lo que sugiere que este hallazgo depende del contexto socioeconómico local.



$p = 0.001$

Coherente con el estudio de Rionegro, donde el inicio promedio de vapeo se ubicó hacia los 13.8 años.
Ventana crítica de inicio: 12 - 14 años

INTERPRETACIÓN CLÍNICA Y DE SALUD PÚBLICA



El hallazgo más relevante:
Edad promedio de inicio
fue de 12,8 años.

Una etapa de desarrollo
pulmonar y neurológico
todavía incompleta.

Aunque el estudio **no**
evaluó **desenlaces**
clínicos **respiratorios**,
este dato es preocupante
porque la exposición
temprana a aerosoles de
cigarrillos electrónicos
ocurre en una población
particularmente vulnerable.

Importancia epidemiológica del estudio



Aporte del estudio

- Proporciona evidencia en un municipio intermedio.
- Reduce vacíos de información sobre vapeo en adolescentes.
- Facilita la planificación de intervenciones preventivas.

Los estudios locales son fundamentales para comprender el comportamiento del vapeo fuera de las grandes ciudades colombianas.

CONCLUSIONES

- Aunque la prevalencia del consumo de vapeadores fue baja, se identificó una alta intención de uso entre los participantes, lo que representa un factor de riesgo para el incremento de esta práctica.
- Pese a que la mayoría de la muestra mostró una percepción adecuada del riesgo, esto no fue suficiente para descartar la disposición a probar cigarrillos electrónicos, evidenciando que el conocimiento del riesgo por sí solo no previene el consumo.
- Estos hallazgos subrayan la necesidad de implementar estrategias de intervención orientadas tanto a fortalecer la información sobre los riesgos del vapeo como a desarrollar habilidades para la toma de decisiones.

“Aunque el consumo actual es bajo, la alta disposición a vapear revela una población vulnerable. La oportunidad de prevenir es ahora, no cuando las cifras aumenten.”

¡GRACIAS!